

IMC - 31.22

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

MARIA DA GRAÇA SOUZA PINTO

IDADE: PESO: 85 ALTURA: 1.65 PROFISSÃO:
SINTOMAS:
QUEIXAS: cansaço / sonolência durante dia
MEDICAMENTOS: Rintexde / lito / Quetiapina / dipacoti
Calao / ferro / simvastatina
MÉDICO: Dra Thamires Maia
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N
EXERCÍCIO FÍSICO: musculação / funcional
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 21h HORA QUE ACORDA: 6h
COCHILO ☒ SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: —
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2 a 3X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 36,5 SPO2: 81%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: SpO2 93%
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

28/02/24 Avaliação

06/03/24 melhora da sonolência
Banheiro 1x.

P = 4-12 (perc 95% = 9.9 / med 7.0)

IAH = 1.1 e/ev

m. de uso = 8h48'

boa.

15/03 P = 6.4 (med) - Perc. 95% 8.5

24 IAH = 0.9 e/ev

m. de uso: 7h.

Bem adapt., s/ queixas de cansaço.

boa.

05/04 P = 6.4 cmH₂O

24 IAH = 0.5 e/ev

m. de uso: 7h6'

Relata melhora do

quadro

compreu.

boa.

17/05 P = 6.4 cmH₂O

24 IAH = 0.5 e/ev

m. de uso: 6h43m

Bem adaptada

Natasha

19/07 P = 6.4 cmH₂O

24 IAH = 0.6 e/ev

m. de uso: 6h

fuga = 0.0

boa

06/09
2024 P=6,4cmH2O
IAH=0,3 elh
muro=4h59'
fuga=0,3 el/min

→ Bem adaptada

relata dificuldade pegar no sono depois
que volta do banheiro de madrugada
↳ evita a própria respiração

* hoco filtro SSO e filtro máx N30 *

22/11
2024 P=6,4cmH2O
IAH=0,8 elh
muro=4h35min
fuga=2 l/min

Queixa de suor orem da própria respiração

hoco máx. swift (M)

hoco filtro máx N30

Silvia

21/02
2025 P=6,4cmH2O
IAH=0,7 elh
muro=7h30min
fuga=0,2 el/min

Bem Adaptada

hoco filtro

Silvia

Depakot + Alanzapina } teve crise
↑ lítium ↑ Ketapina } Bipolar

Nome: MARIA DA GRAÇA SOUZA PINTO

Data de Nascimento: 31-7-1978

IMC: 31,22

Sexo: Feminino

Data do exame: 12-02-2024

Peso: 85 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DRA. THAMIRES MAIA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 12-02-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 506,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 65,0 e 143,0 minutos. O tempo total de sono foi de 337,0 min, eficiência de 66,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,3%; estágio N2: 60,5%; estágio N3: 14,1%; sono REM: 22,1%. O índice de despertares foi de 15,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 36,5/hora, sendo 37 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 136 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 81%, permanecendo 2,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 48 - 89 bpm e NREM de 49 - 77 bpm.

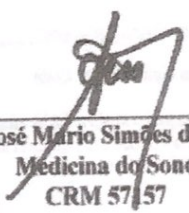
CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 36,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MARIA DA GRAÇA SOUZA PINTO

CPF: 888.281.743-15

Data e hora: 26/02/2024 - 10:50:00 (GMT-3)

Encaminhamento médico

Encaminho a paciente Maria da Graça Souza Pinto, 45 anos, para fisioterapeuta especialista em distúrbios do sono para indicação e ajuste de parâmetros de CPAP devido apneia do sono grave (IAH 36 eventos/hora).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 36,5/hora, sendo 37 eventos, 0 mistos e 0 centrais. A SpO2 média foi de 93%, a mínima de 81%, permanecendo 2,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 48 - 89 bpm e NREM de 49 - 77 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 36,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.

Note: O diagnóstico depende da correlação com outros exames.
IAH > 30 horas acordadas.
IAH: 15-30 horas acordadas.
IAH: 05-15 horas acordadas.



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code

Endereço: Rua Canario, 943

Assinado digitalmente por **Thamiris Maia** - CRM 185756 SP

Token (Farmácia): **Y1uPft** - Código de desbloqueio (Paciente): **0183**